

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

OCDS · CUESTIONARIO OBSESIVO-COMPULSIVO DE LA BEBIDA

Obsessive Compulsive Drinking Scale – Evaluación psicométrica del craving, pensamientos intrusivos y descontrol de la ingesta

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial	Obsessive Compulsive Drinking Scale (OCDS)
Autores Originales	Raymond F. Anton, D. H. Moak y P. K. Latham (1995, 1996)
Validación Española	Josep Guardia, C. Segura, J. Gonzalvo, B. Trujols et al. (2001); Bobes et al. (2004)
Tipo de Instrumento	Autoinforme psicométrico dimensional estructurado
Población Diana	Pacientes adultos diagnosticados de Trastorno por Uso de Alcohol en tratamiento de deshabituación
Tiempo de Aplicación	5 a 8 minutos (14 reactivos tipo Likert de 5 opciones)
Formato de Respuesta	Escala ordinal de 5 puntos: 0 (Ninguno / Nada) a 4 (Extremo / Máximo)
Finalidad Clínica	Cuantificación del craving cognitivo y conductual, predicción prospectiva del riesgo de recaída alcohólica y monitorización de eficacia de fármacos anticraving (acamprosato, naltrexona)

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

Uno de los avances neurobiológicos más fructíferos en el estudio de las adicciones ha sido conceptualizar el alcoholismo crónico no sólo como una búsqueda hedónica o un alivio de abstinencia, sino como un trastorno neurocognitivo estrechamente emparentado con el espectro obsesivo-compulsivo. Anton y sus colaboradores adaptaron los ítems de la célebre escala Y-BOCS para construir un modelo específico de **craving** alcohólico.

El modelo teórico de la OCDS descompone la experiencia adictiva en dos dimensiones interactuantes: a) **Componente Obsesivo (Pensamientos)**, que evalúa el tiempo diario dedicado a pensar involuntariamente en beber, la naturaleza intrusiva de dichas ideas, la interferencia en la concentración y la angustia subjetiva que generan; y b) **Componente Compulsivo (Conducta e Impulso)**, que mide la intensidad del impulso o apetencia imperiosa de beber, los esfuerzos infructuosos de resistencia y la incapacidad para frenar la ingesta una vez iniciada.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

Subescala / Factor	Nº Ítems	Ítems Constituyentes y Manifestaciones Evaluadas
Dimensión Obsesiva (OB)	6 ítems	Ítems 1 a 6: Tiempo ocupado por pensamientos sobre la bebida, frecuencia intrusiva, malestar generado, dificultad de desvío atencional y control mental.
Dimensión Compulsiva (CP)	8 ítems	Ítems 7 a 14: Impulso irresistible a beber, pérdida de control volitivo, cantidad ingerida, interferencia laboral y resistencia conductual activa.
Puntuación Total OCDS	14 ítems	Suma global OB + CP (Rango: 0 a 56 puntos; índice compuesto de craving).

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMACIÓN Y REGLAS DE CORRECCIÓN · OCDS

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATINOAMÉRICA

Consistencia Interna	Alfa de Cronbach global = 0.89 a 0.92 en pacientes españoles en deshabituación (Guardia et al., 2001). Subescala Obsesiva = 0.84; Subescala Compulsiva = 0.86.
Fiabilidad Test-Retest	Coefficiente de correlación intraclass ICC = 0.85 a 0.88 tras intervalo de 7 días en pacientes abstinentes estables.
Validez Predictiva	Puntuaciones OCDS elevadas al finalizar la desintoxicación hospitalaria predicen con un 84% de exactitud la recaída en consumo en los siguientes 90 días.
Sensibilidad Terapéutica	Detecta con precisión la amortiguación del craving inducida por fármacos neuromoduladores glutamatérgicos/opioides (acamprosato, naltrexona, nalmefeno).

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

- Calificación de Cada Ítem (0 a 4):** Cada reactivo tiene 5 anclajes específicos graduados de menor a mayor severidad (0 = Nada/Ninguno; 4 = Constante/Incontrolable).
- Cálculo de Subescalas:**
 - Subescala Obsesiva:** Suma de ítems 1 al 6 (Rango: 0 a 24).
 - Subescala Compulsiva:** Suma de ítems 7 al 14 (Rango: 0 a 32).
- Puntuación Total OCDS:** Suma de los 14 reactivos (Rango: 0 a 56 puntos).
- Marco Temporal:** Se administra habitualmente referida a los últimos 7 días previos a la consulta.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Puntuación Total	Nivel de Craving	Riesgo de Recaída	Directriz Asistencial Recomendada
0 a 7 puntos	Mínimo / Ausente	Bajo (< 15%)	Abstinencia estable; mantener soporte psicoterapéutico.
8 a 17 puntos	Craving Leve	Moderado (30%)	Entrenamiento en detección de estímulos disparadores.
18 a 29 puntos	Craving Moderado	Elevado (60%)	Intensificación psicoterapéutica; optimizar fármacos anticraving.
30 a 56 puntos	Craving Severo	Extremo (> 85%)	Peligro inminente de recaída; valorar hospitalización de día.

VALOR PREDICTIVO DE LA SUBESCALA COMPULSIVA (CP >= 12): El estudio de Anton et al. (1996) demostró que puntuaciones en la subescala Compulsiva superiores a 12 puntos son el predictor independiente más potente de fallo en la abstinencia y abandono del tratamiento ambulatorio en las primeras 4 semanas.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y DIRECTRICES · OCDS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA E INTERVENCIÓN

Paso 1: Administración Semanal durante la Fase de Deshabitación: Complimentar por el paciente en cada sesión ambulatoria.

Paso 2: Conducta Asistencial:

- Si OCDS ≤ 7 : Reforzar la autoeficacia y mantener el plan de seguimiento quincenal.
- Si OCDS 8-17 (**Craving Leve**): Ensayar técnicas conductuales de distracción, demora de 15 minutos ante el impulso y control de estímulos (no tener alcohol en el domicilio).
- Si OCDS ≥ 18 o **Subescala Compulsiva** ≥ 12 :
 1. Prescribir o titular fármacos anticraving de primera línea: Acamprosato (666 mg cada 8 horas) o Naltrexona (50 mg/día).
 2. Si coexiste insomnio disfórico severo, valorar anticonvulsivantes con evidencia anticraving (Topiramato o Gabapentina).
 3. Aumentar la frecuencia de sesiones de terapia grupal de prevención de recaídas.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO (VIGNETTE)

Identificación: Varón de 43 años, taxista, en tratamiento de deshabitación alcohólica tras desintoxicación hospitalaria completada con éxito hace 3 semanas. Acude a consulta semanal manifestando angustia por “no poder sacarse la cerveza de la cabeza”.

Evaluación Psicométrica Inicial en OCDS: Total = 34 / 56 puntos (Craving Severo, Alto Riesgo de Recaída).

- **Subescala Obsesiva:** 18 / 24 puntos. Reporta pasar más de 4 horas diarias rumiando sobre beber (ítem 1 = 3), con interferencia grave en su concentración (ítem 3 = 3) y angustia severa (ítem 4 = 4).
- **Subescala Compulsiva:** 16 / 32 puntos. Siente un impulso violento al pasar frente a las terrazas de los bares (ítem 7 = 3) y duda de poder resistir el fin de semana (ítem 10 = 3).

Manejo Terapéutico: La OCDS objetivó un craving obsesivo extremo que anticipaba una recaída inminente. Se introdujo acamprosato a dosis de 1998 mg/día combinado con sesiones de terapia cognitivo-conductual centradas en manejo de urgencias de consumo (**urge surfing** o surfear el impulso) y reestructuración de permisos cognitivos (“por una caña no pasa nada”). A las 4 semanas, la puntuación total en la OCDS cayó a 8 puntos (descenso del 76.4%), logrando el paciente sortear el período crítico sin consumos.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

ALERTAS CRÍTICAS DE RECAÍDA

- Un incremento abrupto de ≥ 10 puntos en la OCDS respecto a la semana previa anuncia casi invariablemente una recaída en las siguientes 48 horas.
- Puntuaciones altas en pacientes que conducen vehículos comerciales exigen suspensión temporal de la actividad laboral por riesgo de consumo súbito.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

- **Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC):** En el TOC las obsesiones son egodistónicas y no hedónicas; en la OCDS el pensamiento busca el consumo.
- **Craving por Otras Drogas:** Si existe policonsumo (cocaína o benzodiacepinas), aplicar inventarios multidimensionales complementarios.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

- Anton, R. F., Moak, D. H., & Latham, P. K. (1995). The Obsessive Compulsive Drinking Scale: A self-rated instrument for the quantification of thoughts about alcohol and drinking behavior. *Alcoholism: Clinical and Experimental Research*, 19(1), 92–99.
- Guardia, J., Segura, C., Gonzalvo, B., Trujols, J., & Tejero, A. (2001). Estudio de validación de la versión española del Obsessive Compulsive Drinking Scale (OCDS). *Medicina Clínica*, 117(17), 646–652.
- Anton, R. F., Moak, D. H., & Latham, P. K. (1996). The Obsessive Compulsive Drinking Scale: A new method of assessing outcome in alcohol clinical trials. *Archives of General Psychiatry*, 53(3), 225–231.
- Bobes, J., García-Portilla, M. P., Bascarán, M. T., Sáiz, P. A., & Bousoño, M. (2004). *Banco de instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría clínica* (3.ª ed.). Ars Médica.